הקבלה במרפאת טרום ניתוח

תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים: מה כותבים, איפה ואיך

1 הערות כלליות

- כותבים על קוד של מתמחה? **לציין שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר.**
- כל נושא נרשם ברובריקה המתאימה בקמיליון: תרופות קבועות תחת תרופות קבועות, ניתוחים תחת ניתוחים וכן הלאה.
- בסוף הקבלה: **מדפיסים וחותמים.**
- **לא משאירים דבר לאשפוז.** התורן בלילה עמוס בקבלות מהמיון ולא יספיק לעשות אק״ג שלא בוצע. סוגרים הכול בטרום.
- בדיקות שלא הגיעו או שצריך לחזור עליהן: אפשר לבקש שיישלחו בפקס למזכירת המחלקה, 08-9441790.

2 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

3 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** רשימת מחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך, תחת רקע.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח, הפתולוגיה הרלוונטית והאם יש גרורות מרוחקות. יש גרורות? מדברים עם המתמחה. מציינים תאריך. בלי העתק־הדבק, רק ממצאים רלוונטיים.
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- תמיד מבקשים סיכום מרופא המשפחה אם המטופל הביא. זה חוסך המון זמן בתרופות ובמחלות הרקע.
- תמיד מציינים מי הכירורג שהפנה לניתוח ומה האינדיקציה.

4 לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה גופנית: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- לשאול על הפרעות במתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת ניתוחית: אילו ניתוחים קודמים ומתי.

בריאטריה

- BMI, מחלות רקע ואינדיקציה לניתוח. לעבור על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- להעתיק את הבדיקות: שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה, TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוחים קודמים כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- לפי מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה לניתוח.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- בירור כרונולוגי: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי ובדיקה גנטית.
- שיתוף פעולה מתוכנן עם פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי ותוצאותיו: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור בבדיקות אחריו.
- פתולוגיה (כולל MMR), סמנים ו-MRI.

הפטוביליארי

- לאיזה ניתוח מועמד/ת, התייצגות וסיבת הבירור.
- מהלך הבירור המקומי והסיסטמי, לפי תאריכים.
- EUS ו-MRI: יחס לכלי דם ומבנים חשובים.
- פתולוגיה ומרקרים אם ידועים.
- פרוצדורות קודמות: ניקוז דרכי מרה, ERCP.
- מעבדה: רגילה ועוד אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

5 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **IHD:** כמה צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות (פלביקס, אספירין). מתי יפסיק לפני הניתוח. אישור קרדיולוג עם התייחסות לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **PAF:** הטיפול הקבוע.
- **אירועים מוחיים:** מתי ומה.
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון הניתוחי.
- בכל מחלת רקע: יש ייעוץ? מה הוא אומר על הסיכון הניתוחי? צריך ייעוץ שלא נעשה? לציין.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים הקיימים.

6 בדיקות טרום ניתוח

בסביסטון יש פרק עם טבלת הבדיקות הנחוצות. יש גם נהלי מחלקה. אק״ג, צילום חזה ובדיקות דם: מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	לפרט. אין, או באיכות לא טובה? חוזרים על אק״ג.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים תיאור. יש CT חזה? לא צריך צילום. מציינים זאת ברובריקה ומפרטים את ה-CT בקבלה.
בדיקות דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים. קריאטינין, נתרן, אשלגן. INR. ובדיקות רלוונטיות נוספות: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. מציינים ברובריקה את תאריך הבדיקות.
לא עדכניות?	מכתב הפניה לרופא המשפחה עם הבדיקות הספציפיות. מבקשים מהמטופל להגיע ליום הניתוח עם תוצאות עדכניות.

7 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- הניתוח לא מופיע ברשימה? לא מבזבזים זמן: כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

8 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, כמה פעמים ביום ודרך המתן.
- מתי הופסקו נוגדי הקרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן) ומה האינדיקציה להם.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים סביב הניתוח.

והכי חשוב: להפעיל שיקול דעת ולשאול את המתמחה בכל שאלה.